

Información Paciente

Nombre : Fritz Joseph Dortilus

Edad : 62a 6m 6d

Dirección : Pasaje Estacioncortealto 3172

Rut : 26.060.111-3

Fecha Nacto: 01/09/1960

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2303073

Sexo : Masculino

Teléfono : 231654987

N° Epicrisis

344130

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 14/02/2023 01:26

Días Estadía: 21

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 07/03/2023 16:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Anemia Por Deficiencia De Vitamina B12, Sin Otra Especificac

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES:

- Mórbidos: anemia sin estudio, hipertensión arterial diabetes mellitus

- Fármacos: (-)

- Quirúrgicos:

- Alergias: (-)

- Hábitos: tabaquismo (-), alcohol (-), drogas (-)

- Social: paciente haitiano, acompañado al ingreso por familiar que no habla español fluido. No se cuenta con otros antecedentes, hospitalizaciones previas ni consultas en Atención Primaria.

- Hospitalizaciones recientes: (-)

Paciente sin antecedentes conocidos o registrados en la histórica clínica, consultó el 04/02/2023 al servicio de urgencias por cefalea, mialgias y tos de una semana de evolución, donde fue dado de alta a su domicilio con diagnóstico de cefalea en contexto de infección respiratoria alta.

El 13/02 es traído por familiar por cuadro clínico de aproximadamente tres días de evolución caracterizado por astenia, adinamia, alteraciones en la marcha y compromiso progresivo de conciencia. Destaca al examen físico: somnolencia, apertura ocular al estímulo táctil, ictericia, edema bilateral de extremidades inferiores, taquicardia hasta 117, hipertensión (155/93), fiebre hasta 39°C e hiperglicemia. Se solicita exámenes de laboratorio donde destaca: dímero D 8180, INR 1.6, lactato 25, bilirrubina T 2.7 / D 1.15, GOT/GPT 58/19, crea 1.65, TUS 117, glucosa 545, LDH 5657, Hb 4.8, Hcto 15%, PLQ 45.000 y PCR SARS COV 2 negativo. Se sospecha anemia hemolítica / púrpura trombótico trombocitopénico, pero se decide no transfundir para preservar posibilidad diagnóstica.

El 14/02 es evaluado por Hematología, que indica ¿por el momento no corticoides dada hiperglicemia y poca claridad respecto al origen de la anemia. Transfundir glóbulos rojos en caso necesario¿. Evoluciona con mayor compromiso de conciencia, requiriendo protección de vía aérea. Se realizó TAC de cerebro, evaluada por neurología, a quienes impresiona imágenes compatibles con infarto constituido occipital derecho de aspecto subagudo (arteria cerebral posterior) e infarto talámico izquierdo de aspecto crónico. Además, destaca colección subdural de la convexidad izquierda sugerente de hematoma subdural. Sin otras lesiones parenquimatosas evidentes.

Se realiza TAC de tórax, abdomen y pelvis que evidencia signos tomográficos de edema alveolar asociado a leve derrame pleural bilateral, manifestación tomográfica de sobrecarga de volumen (anasarca). Moderada cardiomegalia global.

Fecha Epicrisis : 07/03/2023 13:31

Durante estadía en el Servicio de Urgencias evoluciona con mayor compromiso de conciencia (Glasgow 7) asociado a desaturación y deterioro hemodinámico, por lo que se realiza intubación orotraqueal y se decide hospitalización en UCI para estudio y manejo.

EXÁMENES DE INGRESO:

14/02: Hb 4.8 Hcto 15.0 VCM 115.0 GB 4300 Pla_q 45000 INR 1.61 TTPA 29.4 lactato 25.8 PCR 6.6 Crea 1.65 BUN 33.8 ELP 151/4.78/117 Ca 9.6 Alb 3.6 ProtT 7.4 LDH 5657 GOT 58 GPT 19 FA 60 GGT 25 BilT 2.70 BilD 1.15 Glu 545 DD 8180 TUS 117.6 GSV: pH 7.433 pCO₂ 39.5 HCO₃ 25.8

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UCI:

1. - Shock indiferenciado
- Falla orgánica múltiple (hemodinamia, renal, cardíaca).
- Infarto temporo-occipital derecho subagudo (arteria cerebral posterior)
- Compromiso de conciencia
- Bicitopenia (Anemia aguda y severa + Trombocitopenia)
- Obs púrpura trombótico trombocitopénico.
- Hiperglicemia severa - No cetoacidosis diabética / Obs. síndrome hiperglicémico hiperosmolar.

EVOLUCIÓN POR PLANES:

- Hemodinamia: ingresa el 13/02 hemodinámicamente estable, con buena perfusión distal. El 14/02 evoluciona con compromiso hemodinámico tras intubación orotraqueal, con requerimiento de noradrenalina hasta 0,09 ug/Kg/min. A su ingreso a UCI se realiza ecoscopia: TSVI 15, ventrículo derecho menor a ventrículo izquierdo, hipocinesia a nivel de la punta del ventrículo izquierdo, sin evidencia de neumotórax, sin evidencia de líquido libre en cavidad abdominal; vena cava inferior sin variabilidad. Evoluciona con rápida disminución de requerimientos de drogas vasoactivas, siendo suspendidos el 15/02. Posteriormente evoluciona con tendencia a la hipertensión, iniciándose antihipertensivos orales. Permanece hipertenso por lo que se realiza ajuste de antihipertensivos, con buena respuesta.

- Respiratorio: ingresa al servicio de urgencias sin compromiso ventilatorio. Evoluciona el 14/02 con mayor compromiso de conciencia (Glasgow 7) asociado a desaturación y rápido deterioro, por lo que se realiza intubación orotraqueal para ventilación mecánica invasiva. Evoluciona sin conflicto ventilatorio ni de intercambio gaseoso. El 19/02 se inicia proceso de weaning el cual resulta dificultoso dado mal despertar Obs. delirium hiperactivo que requiere dexmedetomidina, logrando concretarse el 23/02 sin incidentes. Actualmente sin requerimiento de O₂. Sin nuevas interurrencias durante la hospitalización.

- Cardiológico: a su ingreso electrocardiograma con T negativas en pared inferior y lateral; junto con elevación de troponinas con posterior descenso (Obs. infarto agudo al miocardio tipo II). Se solicita ecocardiograma para evaluar secuelas del evento descrito; pendiente realización. Se entrega orden para realizar en ambulatorio.

- Hematológico: al laboratorio de ingreso destaca bicitopenia con anemia severa + trombocitopenia severa, Obs. microangiopatía trombótica dado marcadores de hemólisis (+), falla renal y compromiso neurológico. Evaluado el 14/02 por hematología, quienes indican plasmaféresis, realizándose la primera sesión el 15/02 y posteriormente el 16-17-18-19/02, completando 5 sesiones. Durante estadía en UCI requiere transfusión de 7 U de glóbulos rojos y 7 U plaquetas, evolucionando con caída de 1 punto de hemoglobina y plaquetas en disminución, pero sin exteriorización de sangrado. Se indican pulsos de metilprednisolona, completando 3 días e iniciando posteriormente dexametasona. Dentro de estudio etiológico destaca C3/C4 bajos, B12 baja, fibrinógeno normal, FR bajo, IR en 2.5, ANA (-), anti-DNA (-), Coombs directo (+), VIH (-), serologías VHB y VHC (-) y PCR CMV (-). Haptoglobina, estudio de SAF y ADAMTS13 por convenio pendiente. Se inicia aporte de vit B12 + ácido fólico, con estabilización de hemoglobina.

El 20/02 es evaluado nuevamente por hematología, quienes interpretan hemograma con frotis no compatible con púrpura trombótico trombocitopénico dado alteraciones inespecíficas de glóbulos rojos con esquistocitos sólo 1+, atribuyendo cuadro a anemia por deficiencia de B12 y sugiriendo iniciar suplementación; tras lo cual mejora perfil hematológico y disminuye LDH. Pendiente precisar etiología con endoscopia digestiva alta, anticuerpos anti células parietales y anti factor intrínseco. No queda claro la etiología de hipocomplementemia con coombs (+), por lo que se solicitan niveles de inmunoglobulinas para descartar falsos positivos, en rango normal.

El 06/03 se lleva a endoscopia, sin embargo el paciente agrede al personal por lo que no se logra realizar el procedimiento. Se entrega orden para realizar en ambulatorio..

- Neurológico: evaluado al ingreso por equipo dado compromiso de conciencia de evolución subaguda en contexto de fenómenos embólicos con infarto cerebral en territorio de arteria cerebral posterior derecha, se notifica GES accidente cerebrovascular isquémico y se indican medidas de neuroprotección. Es evaluado el 15/02 por neurocirugía, quienes desestiman necesidad de resolución quirúrgica. Manejo de delirium hiperactivo durante la hospitalización. Se realiza Holter de

Fecha Última Actualización: 07-03-2023 13:31:16

Página 3 de 4

rítmo el 02/03 como estudio de fuente embólica, rescatar resultado en controles. Entrego orden para realizar ecocardiograma en ambulatorio.

- Renal/medio interno: ingresa cursando falla renal aguda KDIGO I (crea 1.73, no se cuenta con basal) y oligoanuria, sin criterios de urgencia dialítica. Evolucionan en UCI con Obs. globo vesical, por lo que se indica cambio de sonda + orina completa/urocultivo, e hipernatremia severa (Na^+ 156), iniciándose aporte de agua libre/Suero glucosado 5% con buena respuesta. El 25/02 evoluciona con hipokalemia que requiere carga EV de potasio. Posteriormente con buena función renal, electrolitos en rango. Sin nuevas interurrencias durante la hospitalización.

- Infeccioso: ingresa afebril, con parámetros inflamatorios bajos. A su ingreso en UCI destaca crecimiento en cultivo de aspiración endotraqueal de *S. aerus* 100.000 UFC multisensible, tratado con Ampicilina/Sulbactam por 5 días, con buena respuesta. Sin nuevas interurrencias durante la hospitalización.

- Metabólico: ingresa con hiperglicemia severa, Obs. síndrome hiperglicémico hiperosmolar, con requerimientos de BIC de insulina. Además, con componente corticoidal importante. Inicialmente persiste con requerimientos de insulina cristalina tras suspensión de BIC. Evolucionan con criterios de resolución, con hemoglucotest en rango. HbA1c en 4.9%, resultado no interpretable en contexto de anemia. Recibiendo soporte nutricional mixto, bien tolerado.

- Gastrointestinal: evoluciona con pruebas hepáticas alteradas sin un patrón específico; se mantiene en observación, evolucionando con mejoría espontánea de los exámenes. Sin conflicto durante la hospitalización.

- Nutrición: una vez estabilizado hemodinámicamente, se inicia Embrace a 30 cc/hr por sonda nasogástrica, bien tolerado. El 06/03 se retira sonda, procedimiento sin incidentes. Posteriormente alimentándose por vía oral con buena tolerancia.

- Profilaxis: tromboprofilaxis con enoxaparina. Sin conflicto durante la hospitalización.

- Social: barrera de lenguaje, paciente no habla español. Se solicita asistencia de traductor para entregar indicaciones.

LABORATORIO RELEVANTE:

06/03: Hb 8.9 Hcto 28.4 VCM 91.7 GB 10770 Plaq 702000 Crea 0.83 BUN 13.4 ELP 136/4.07/106 Mg 1.8 P 32 Ca 8.7

03/03: IgA 341 IgG 1889 IgM 113

01/03: HbA1c 4,9% Perfil de hierro: Fe 27 TIBC 153 SatT 18% (P) AC anti células parietales y anti FI

21/02: Hemograma: Anisocitosis ++ Macrocitosis + Hipocromía + Poiquilocitosis ++ Ovalocitos + Esquistocitos + Target Cell + Policromatofilia + Anisocromía + Punteado basófilo +. Reticulocitos 7,8%

20/02: Haptoglobina 103 (normal)

15/02: vitB12 148 anticardiolipinas (-) C4 10 (bajo) C3 51 (bajo) fibrinógeno 188 antiDNA (-) FR (-) VHS 8.0 ANCA (-) anticoagulante lúpico (-)

14/02: Hb 4.0 Hcto 12.8 VCM 110.1 GB 4390 RAN 1800 RAL 2500 Plaq 43000 INR 1.83 TTPA 30.9 lactato 11.8 PCR 8.5 PCT 0.46 Crea 1.56 BUN 31.5 ELP 157/3.94/128 P 3.3 amonio 0.86 Mg 2.4 Ca 9.0 Ca iónico 4.7 LDH 4437 BilT 2.18 BilD 1.01 GOT 52 GPT 18 FA 45 GGT 23 Glu 252 lipasa 48 amilasa 66 TUS 495.8 CKT 54 CKMB 15 ColT 88 GSA: pH 7.521 pCO2 32.6 HCO3 26.14 SatO2 99.6 GSV: pH 7.466 pCO2 40.0 HCO3 28.2

MICROBIOLOGÍA:

14/02: SO no inflamatorio, UC (-) cetonuria (-) PCR COVID (-) HC I y II (-) CAET (+) *S. aureus* 1.000.000 UFC MS.

15/02: VIH (-) VHC NR VHB NR

16/02: OC no inflamatoria UC (-)

17/02: PCR CMV (-)

IMÁGENES:

TAC de tórax, abdomen y pelvis 14/02: Signos tomográficos de edema alveolar asociado a leve derrame pleural bilateral, manifestación tomográfica de sobrecarga de volumen (anasarca). Moderada cardiomegalia global.

14/02 TAC cerebro: Sin informe. (infarto cerebral en territorio de ACP derecha).

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

1. Shock indiferenciado resuelto

- Intubación orotraqueal 14/02 - 23/02

2. Bicitopenia (Anemia aguda y severa + Trombocitopenia)

- Plasmaféresis 15/02 + pulsos de corticoides.

- Déficit severo de Vitamina B12 en suplementación.

3. Infarto temporo-occipital derecho subagudo (arteria cerebral posterior)

4. Infarto agudo al miocardio tipo 2.

5. Delirium mixto.

6. Hiperglicemia severa corregida.

Fecha Epicrisis : 07/03/2023 13:31

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 07-03-2023 13:31:16

Página 4 de 4

7. Falla renal aguda KDIGO II resuelta.
8. Hipernatremia severa resuelta.
9. Hipercloremia severa resuelta.

Diagnóstico de Egreso

Anemia en estudio -

Condición de Egreso Alta

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente HDN estable, normocárdico, afebril, sin requerimientos de O2 suplementario. Alimentándose por vía oral. Exámenes de laboratorio estables. En condiciones de alta hospitalaria.

Plan Post Alta

INDICACIONES GENERALES:

- Reposo relativo asistido.
- Régimen bajo en sodio, 200 g de carbohidratos.

FÁRMACOS:

- Losartán 50 mg cada 12 horas vía oral.
- Amlodipino 10 mg al día vía oral.
- Hidroclorotiazida 25 mg al día vía oral.
- Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos en caso de fiebre o dolor.
- Ácido fólico 5 mg al día vía oral.
- Tol12 inyectable 10.000 mcg al día intramuscular, 1 dosis en 1 mes (para completar 3 dosis en total).

CONTROLES:

- Realizar endoscopía digestiva alta (entrego orden).
- Tomar exámenes de control (entrego orden).
- Realizar ecocardiograma transtorácico (entrego orden).
- Control con Medicina Interna en 1 mes con resultados de exámenes.
- Control en consultorio para ajuste de antihipertensivos

CONSULTAR EN SERVICIO DE URGENCIAS EN CASO DE sangrado abundante, dificultad respiratoria, compromiso de conciencia, dolor torácico opresivo, fiebre >38°C persistente, dolor que no cede con analgesia, o en caso de que estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : 200 G Carbohidratos, Bajo En Sodio

Medicamentos : Paracetamol 500mg 2 Comprimidos Via Oral Si Fiebre O Dolor
Losartan 50mg Cmp 50 Mg Cada 12 H Via Oral
Hidroclorotiazida 50mg 25 Mg Al Dia Via Oral
Amlodipino 10 Mg Al Día Via Oral
Acido Folico 5mg Cmp 5 Mg Al Dia Via Oral

Controles

S/F - CDT - Medicina Interna -

INTERNO

Becado/Residente

Constanza Andrea Jara Jara
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 07/03/2023 13:31

Página 4 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:54

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar